



תפוצה: מחלקת נשים ויולדות	תחום הנוהל: מיילדות		תאריך פרסום: מאי 2017 תאריך עדכון
	שם הנוהל: העברת וקליטת יולדת מבית חולים אחר		
מס' דפים: 6	כותב הנוהל: דר' יובל גינסברג על החתום:	מאשר הנוהל: פרופ' זאב וינר על החתום:	נספחים: 1. העברה יולדת לבית חולים אחר - רשימת תיוג

רשימת עכונים

מהדורה	מהות העדכון	שם המעדכן ותפקיד	תאריך

מילות מפתח (KEY WORDS)

העברת יולדת לבית חולים אחר, קליטת יולדת מבית חולים אחר
--

תוכן העניינים

הנושא	עמוד
1. רקע	2
2. מטרות הנוהל	3
3. הגדרות ומונחים	3
4. סמכות ואחריות	3
5. שיטת העברה	4
6. דיווח ותיעוד	5
7. סימוכין (אסמכתאות)	5
8. נספחים	6

1. רקע

- 1.1 העברה וקליטה של יולדת אל/מ בית חולים אחר תתכן מטעמים מיילדותיים או בהוראת רופא הילדים (תאום פגיות).
- תהליך העברתה של יולדת מחוץ לבית החולים עלול להיות מורכב ומחייב תאום מוקדם, הערכות רפואית, מנהלית, לוגיסטית ולעיתים מחייבת התאמת צוות ייעודי מיומן.
- 1.2 בכל העברה או קליטה של יולדת יש להקפיד על נוהל העברה מסודר.
- ההעברה מחייבת תאום עם חדר הלידה אליו היולדת מועברת, תאום פגיות (יש לתעד אישור רופא פגייה), הכנת היולדת והציוד (באם נדרש) להעברה.
- בכל מקרה של ההעברה יש לוודא הגעתה של היולדת בבטחה לחדר הלידה הקולט.
- העברת/קליטת יולדת מבית חולים אחר בשעות הבוקר מחייבת אישור מנהל חדר לידה, מנהל החטיבה או מי מטעמם (בשעות התורנות – יש לקבל את אישור הכונן).
- עם הגעת היולדת יש לדווח לבית החולים ממנו הועברה ולבצע קבלה רפואית וקבלה סיעודית כמקובל.

1.3 העברת המידע אודות היולדת תבוצע באופן שיטתי על פי עקרונות המרא"ה (ISBAR) ראה נהל "הליך העברת מידע בין מטפלים באופן שיטתי ומתן הוראות רפואיות בעל פה")

2. מטרת הנהל

קביעת כללים להעברת יולדת ו/או קליטת יולדת מבית חולים אחר תוך שמירה על רצף הטיפול, בטיחות הטיפול ונוחות המטופלת.

3. הגדרות ומונחים

- 3.1 **העברה דחופה:** קיים צורך מידי להעברת היולדת לשם הצלת חיים או מניעת נזק בלתי הפיך ליולדת ו/או לעובר.
- 3.2 **העברה מתוכננת:** העברה אשר מאפשרת התארגנות מוקדמת.
- 3.3 **אמצעי תחבורה -** רכב מותאם של ביה"ח או לחילופין אמבולנס לבן (מד"א) או נט"ן

4. סמכות ואחריות

- 4.1 העברת יולדת/קליטת בשעות הפעילות יולדת מחייבת אישור של אחד מהנ"ל: מנהל חדר לידה, מנהל מחלקת היריון בסיכון, סגן מנהל החטיבה או מנהל החטיבה. במהלך תורנות אישור העברה/קליטה של יולדת בסמכות הכונן.
- 4.2 ניהול ההעברה/קליטה בפועל, הכנת היולדת להעברה, התאום עם חדר הלידה הקולט/מעביר, ווידוא ההעברה הנם באחריות התורן האחראי או הרופא האחראי במהלך היום.
- 4.3 הכנת או קליטת היולדת באחריות רופא + מיילדת.
- 4.4 קביעת הדחיפות תקבע באחריות הרופא הבכיר הנוכח. מקביעת הדחיפות ייגזרו הנושאים הבאים:
 - 4.4.1 אמצעי הניטור הנדרשים והציוד הלוגיסטי הנדרש במהלך ההעברה.
 - 4.4.2 צוות מלווה (העדר מלווה, רופא מיילד + רופא פגיה.
 - 4.4.3 אמצעי תחבורה - רכב מותאם של ביה"ח או לחילופין אמבולנס / אחר חיצוני מטעם ביה"ח

4.5 בטיחות בהעברה.

הרמת דפנות מיטה, וידוא תקינות הציוד (באם נידרש) ווידוא תקינות ההתראות (באם קיימות), וידוא כי היולדת בתנוחה יציבה ואינה חשופה לסכנת נפילה או פגיעה בעת ההעברה.

5. שיטת ההעברה

5.1 הכנת היולדת להעברה

- 5.1.1 יש לוודא כי בידי היולדת (או המלווים) מכתב העברה מפורט.
- 5.1.2 יש לוודא כי במכתב מפורט מצבה העכשווי של היולדת והעובר, פירוט הבדיקות שעברה במהלך שהותה במחלקה, הסיבה בגינה מועברת היולדת, ופירוט מכלול הטיפולים שניתנו ליולדת במהלך שהותה במחלקה. (בדגש על טיפול טוקוליטי (באם ניתן), מתן סטרואידים, אנטיביוטיקה וכו')
 - 5.1.3 יש לעדכן את האחות האחראית בצורך לשינוע.
 - 5.1.4 לאחר תאום עם המוסד הקולט, יש לתאם עם **מוקד הבקרה** בבית החולים (טלפון פנימי 1234 , 2303) את אמצעי שינוע המטופל והלווי הנדרש וזאת על פי הנחיות הרופא המטפל.
 - 5.1.5 יש למלא "טופס העברת מטופל למוסד רפואי אחר" (נספח מספר 1) שליחתו בפקס למוקד הבקרה בכל שעות היממה. טופס יופיע פירוט פרטי המטופל כולל **שם ושם משפחה, מספר תעודת זהות**, יעד ההעברה, הגורם עמו תואמה ההעברה, דחיפות ההעברה, אמצעי ההעברה ופרטים נדרשים רלבנטיים נוספים טופס זה ישלח באמצעות **פקס פנימי שמספרו 3396** למחלקת השינוע וכן **לפקס של מוקד בקרה שמספרו 1238** על האחות לוודא קבלת הפקס ביחידת השינוע ומוקד הבקרה ולתאם את שעת ההעברה.
 - 5.1.6 מוקד הבקרה יעדכן את האחות האחראית לגבי זמינות השינוע ומועד ההעברה המדויק.
 - 5.1.7 באחריות מוקד הבקרה לוודא הגעת המטופל אל היעד ולעדכן את האחות האחראית במשמרת.
 - 5.1.7 אחראית המשמרת תתעד ברשומת המטופל את הגעתו ליעד המתואם.

5.2 בטיחות בהעברה.

הרמת דפנות מיטה, וידוא תקינות הציוד (באם נדרש) ווידוא תקינות ההתראות (באם קיימות), וידוא כי היולדת בתנוחה יציבה ואינה חשופה לסכנת נפילה או פגיעה בעת ההעברה.

5.3 צוות מלווה: במידה ונידרש צוות מלווה (החלטת תורן אחראי) יצורפו להעברה רופא מיילד ורופא פגייה.

5.4 קליטת יולדת תבוצע כמקובל (קליטה רפואית וקליטה סיעודית) כולל אנמנזה, בדיקה גופנית ובדיקות נוספות בהתאם לנדרש.

6. דיווח ותיעוד

6.1 העברת יולדת או קליטת יולדת מבית חולים אחר בשעות הבוקר מחייבת אישור של אחד מהנ"ל: מנהל חדר לידה, מנהל מחלקת היריון בסיכון, סגן מנהל המחלקה או מנהל המחלקה. בשעות התורנות האישור להעברת/קליטת יולדת הינו בסמכותו של הכון.

בכל מקרה, השיקולים להעברה יתועדו בגיליון הממוחשב של המטופלת.

6.2 באחריות מוקד הבקרה לוודא הגעת המטופל אל היעד ולעדכן את האחות האחראית במשמרת. אחראית המשמרת תתעד ברשומת המטופל את הגעתו ליעד המתואם

6.3 בהמשך לשיחה עם חדר הלידה אליו הועברה היולדת, יש לתעד בגיליון המטופלת את הגעתה.

7. מסמכים ישימים (סימוכין) :

חוזר מנהל רפואה מס 30/2004 ' מיום 12.12.2004 בנושא " הסעת מטופלים ממוסד אשפוז למוסד אשפוז נהלי שינוע .

http://www.health.gov.il/hozer/mr60_2004.pdf

נספח 1

תאריך: _____:

העברה יולדת לבית חולים אחר - רשימת תיוג-

פעולות מקדימות ליציאת המטופל

- קיימת הוראה רפואית כתובה לגבי ההחלטה על העברת מטופל
- בוצע תאום רפואי עם צוות היחידה הקולטת.
- תאום זמן העברה וקבלת אישור להעברה מהצוות הקולט
- מתן הסבר למטופל ו/או למשפחה במידה ונמצאת לגבי ההעברה .
- תיעוד ממוחשב של סיכום העברה רפואי והעברה סיעודית
- העברת חפצי ערך, עזרים וחפצים אישיים של המטופל

הכנת ציוד

- הצוות המעביר מכיר את המטופל ואת המכשור המחובר למטופל (מוניטור או כל מכשור אחר)

הכנת המטופל לפני יציאה

- בידי היולדת מכתב העברה מפורט
- טרם ההעברה היולדת נבדקה לקיבועים: טובוס (באם קיים), עירוויים, נקזים, משאבות/מזרקי תרופות ובמידת הצורך החלפת שקיות עירוי
- מדידה, הערכה ורישום סימנים חיוניים לפני היציאה. במידת הצורך בדיקת PV חוזרת טרם ההעברה.
- אומדן VAS / FLACC ומתן טיפול בהתאם
- כיסוי, חימום ושמירה על פרטיות המטופל במידת הצורך